TEMA 4 · Gestión de servicios sanitarios y de enfermería. Prestaciones del SNS (Ley 16/2003)

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: Planificación, producto sanitario y enfermero, cartera y recursos humanos · Bloque B: Ley 16/2003 de cohesión y calidad del SNS

Siglas y leyes de este tema

Sigla o norma	Nombre completo	De qué va
SNS / SMS	Sistema Nacional de Salud / Servicio Murciano de Salud	El sistema público estatal / el servicio de salud de Murcia
AP / AE	Atención Primaria / Atención Especializada	Centro de salud / hospital y especialistas
CC. AA.	Comunidades Autónomas	
CISNS	Consejo Interterritorial del SNS	Ministerio + consejeros de las CC. AA.: aprueba la cartera común
CMBD / RAE-CMBD	Conjunto Mínimo Básico de Datos / Registro de Actividad de Atención Especializada	Datos de cada alta hospitalaria
GRD	Grupos Relacionados por el Diagnóstico	Agrupan pacientes de coste parecido
CMDIC	Conjunto Mínimo de Datos de los Informes Clínicos	Datos mínimos de los informes (también el de cuidados de enfermería)
PRN, SIIPS, SIGNO, NIPE, VASS	Sistemas para medir el producto enfermero	Ver A6
EBE / EPA	Enfermería Basada en la Evidencia / Enfermera de Práctica Avanzada	
FCS / FOGA	Fondo de Cohesión Sanitaria / Fondo de Garantía Asistencial	Compensan a la CA que atiende a pacientes de otra
TSI / CIP-SNS	Tarjeta Sanitaria Individual / Código de Identificación Personal del SNS	La tarjeta y su número de por vida
REPS	Registro Estatal de Profesionales Sanitarios	Quién es quién (público y privado)
Ley 16/2003	Ley de Cohesión y Calidad del SNS	Prestaciones, cartera, garantías, CISNS (Bloque B)
RD 1030/2006	Real Decreto de la cartera de servicios comunes del SNS	Qué incluye la cartera (sus anexos)
RDL 16/2012	Real Decreto-ley de medidas urgentes para la sostenibilidad del SNS	Partió la cartera en básica, suplementaria y accesoria
RDL 11/2026	Real Decreto-ley de reforma del copago (según el manual)	Tramos de aportación farmacéutica
RD 1039/2011	Real Decreto de tiempos máximos de espera	180 días para 5 cirugías
RD 69/2015	Real Decreto del Registro de Actividad de Atención Especializada	Regula el RAE-CMBD
RD 1093/2010	Real Decreto del CMDIC	Informes clínicos mínimos
Decreto 25/2006	Decreto murciano de tiempos máximos de espera	150 / 50 / 30 días

Abreviaturas de las normas: **RD** = Real Decreto (lo aprueba el Gobierno); **RDL** = Real Decreto-ley (norma urgente del Gobierno con fuerza de ley, que luego convalida el Congreso).

A1. Gestión sanitaria: tendencias actuales

- **Gestión sanitaria**: planificar, organizar, dirigir y evaluar los recursos (humanos, estructurales, tecnológicos y financieros) para atender de forma óptima y equitativa las necesidades de salud.

- Cambio de paradigma: del modelo biomédico, reactivo y hospitalocéntrico al **cuidado continuo, proactivo y comunitario** (envejecimiento, dependencia, enfermedades crónicas no transmisibles).
- **Plan de Salud de la Región de Murcia 2026-2032**: planificación continua e intersectorial con **4 áreas**: Determinantes de la salud; **Problemas de salud** (incluye salud mental temprana, Eje 2.1, y adicciones, Eje 2.2; planes de cáncer, sida, diabetes); Asistencia sanitaria (reorganización, recursos humanos, modernización del Servicio Murciano de Salud, SMS); y Planificación basada en datos.
- **Cuadro de mando**: panel que reúne los **indicadores clave** de la unidad para decidir rápido y bien; hoy se alimenta de los sistemas de información, las tecnologías de la información y la inteligencia artificial para mejorar la calidad, la eficiencia y la gestión de recursos.

Sistema de información del SMS	Ámbito
SELENE	Atención Especializada (hospital, urgencias)
OMI-AP	Atención Primaria (centros de salud y consultorios)
GACELA	Gestión de cuidados de enfermería; mide el producto enfermero

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
> ! Salud mental y adicciones están en el **Área de Problemas de la Salud**, no en Asistencia Sanitaria.

A2. Planificación: concepto y niveles

Proceso **continuo, sistemático y formalizado** de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado desde una situación analizada. Debe ser flexible, continua y participativa.

Nivel	Plazo	Quién	Qué hace	Producto
Estratégica (normativa, macrogestión)	Largo: 4-10 años	Ministerio, Consejería, alta dirección	Misión, visión, directrices	**Plan** de Salud
Táctica (estructural, mesogestión)	Medio: 1-3 años	Direcciones de área, hospital, enfermería	**Distribuye recursos** (presupuesto, plantillas)	**Programa** de Salud
Operativa (microgestión)	Corto: ≤ 1 año	Supervisoras, coordinadores	Organiza tareas diarias	**Plan operativo**

Los años son orientativos: el manual da 4-10 años a la estratégica, pero otros autores (y el examen del SMS de 2019) hablan de **3-5 años**. Lo que preguntan es la idea: **largo plazo = estratégica**.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
> ! Asignar presupuesto, infraestructuras y plantillas = **planificación táctica**, no estratégica.
> ! **Plan = estratégica; Programa = táctica; Plan operativo / tareas = operativa.**

A3. Planificación operativa

Etapas

1. **Diagnóstico de situación** e identificación de problemas: con métodos **cuantitativos** (indicadores demográficos: densidad, razón de masculinidad, envejecimiento, dependencia) y **cualitativos**, que buscan el consenso de expertos o de la comunidad (**técnica Delphi**, grupo nominal).
2. **Priorización**: métodos **Hanlon** y CENDES-OPS (Centro de Estudios del Desarrollo y Organización Panamericana de la Salud). Los primeros criterios para priorizar son la **magnitud** y la **gravedad** del problema.
3. **Objetivos y metas** (población diana).
4. **Programación** de actividades, recursos y presupuesto.
5. **Indicadores de evaluación** (se diseñan **antes** de ejecutar).
6. **Ejecución**.
7. **Evaluación**.

Método de Hanlon: (A + B) × C × D

Componente	Qué mide	Puntuación
A – Magnitud	Personas afectadas (prevalencia/incidencia)	0-10
B – Severidad	Mortalidad, morbilidad, incapacidad, costes	0-10
C – Eficacia / vulnerabilidad	Capacidad de resolverlo	**0,5 a 1,5**
D – Factibilidad (PERLA)	Pertinencia, Economía, Recursos, Legalidad, Aceptabilidad	**0 o 1**

Otras herramientas de calidad que **no** sirven para priorizar: el **diagrama de Ishikawa** (espina de pescado: busca las causas de un problema), el **flujograma** (dibuja los pasos de un proceso) y el **DAFO-CAME** (análisis estratégico de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades).

Indicadores de Donabedian

Tipo	Mide	Ejemplo
Estructura	Recursos disponibles antes de atender	Ratio enfermera/paciente, colchones antiescaras, protocolo aprobado
Proceso	Lo que se hace sobre el paciente	% de pacientes con escala de Braden al ingreso
Resultado	Efecto final en la salud	Prevalencia de UPP, bacteriemias por catéter, satisfacción

Objetivos, metas, actividades y recursos

- Objetivos **SMART** (específicos, medibles, alcanzables, relevantes, temporalizados).
- **Objetivo general** (propósito a largo plazo) → **objetivo específico** (hitos) → **meta** (cuantificación exacta: "95% antes del 31 de diciembre").
- Actividades: quién, qué y cuándo (**diagrama de Gantt**).
- Recursos: **humanos** (el más importante y costoso: más del 65% del presupuesto), materiales y financieros.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Si un factor PERLA vale 0, **D = 0** y la prioridad total es 0.

! Hacer la escala de Braden = **proceso**; aparición de la UPP = **resultado**.

! Los indicadores se diseñan en la **programación**, no al final.

A4. Gestión de los servicios de enfermería

- **Gestión del cuidado**: juicio profesional en la planificación, organización, motivación y control de los cuidados para lograr una atención óptima, segura y continua.
- **Las 4 funciones de la dirección**: **planificar** (qué se quiere lograr), **organizar** (quién y con qué), **dirigir** (motivar y guiar al equipo) y **coordinar y controlar** (comprobar si se han logrado los resultados previstos y corregir). Ej.: valorar si el paciente alcanzó los resultados de su plan de cuidados = **control**.
- Del modelo **funcional** burocrático (s. XX) a modelos descentralizados centrados en el paciente. Ejes: **enfermera referente** y **gestión de casos** (coordinación sistemática de la atención a **grupos concretos de pacientes** durante un episodio de cuidados); nuevos roles (Enfermera de Práctica Avanzada, **EPA**, e indicación enfermera, RD 1302/2018); **gestión por procesos**.
- **Gestión por procesos**: organizar el trabajo como una cadena de actividades que da un resultado al paciente. Tipos: **estratégicos** (marcan el rumbo: planificación, calidad, alianzas; el EIR incluye aquí la **formación continuada** de los profesionales), **clave u operativos** (la asistencia directa al paciente) y **de soporte** (dan los medios: limpieza, compras, mantenimiento, informática).
- **Enfermería basada en la evidencia (EBE)**: reduce la variabilidad clínica injustificada.
- **Trayectoria o vía clínica**: plan **multidisciplinar, estandarizado y secuenciado en el tiempo** para procesos **predecibles y homogéneos** (prótesis de cadera, cataratas, parto no complicado). Detecta **desviaciones (varianzas)**. El plan de cuidados NANDA, individualizado y flexible, se reserva para pacientes complejos y poco previsibles.

A5. Producto sanitario: CMBD y GRD

- **Producto sanitario**: conjunto de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y cuidados que consume un paciente del ingreso al alta.
- **CMBD** (Conjunto Mínimo Básico de Datos): resumen de cada alta, regulado por el **RD 69/2015** (Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada, **RAE-CMBD**). Es de **Atención Especializada**, no de primaria. Incluye también la Cirugía Mayor Ambulatoria (**CMA**), el **hospital de día**, la **hospitalización a domicilio** y procedimientos complejos en consultas.
  - Variables: identificación (Código de Identificación Personal, CIP, y Tarjeta Sanitaria Individual, TSI), edad, sexo, fechas, circunstancia del alta, diagnósticos y procedimientos codificados con la **CIE-10-ES** (Clasificación Internacional de Enfermedades, 10.ª revisión, edición española; sustituyó a la CIE-9-MC).
  - **Diagnóstico principal**: la condición que, **tras el estudio**, se establece como **causa del ingreso** (no el más grave ni el más costoso).
  - Diagnósticos secundarios: comorbilidades y complicaciones, con marcador **POA** (*present on admission*: presente al ingreso o no).
- **CMDIC** (Conjunto Mínimo de Datos de los Informes Clínicos, **RD 1093/2010**): fija los datos mínimos de los informes clínicos del SNS. En el **informe de cuidados de enfermería** obliga a recoger los **diagnósticos enfermeros activos (NANDA), los resultados (NOC) y las intervenciones (NIC)**.
- **GRD** (Grupos Relacionados por el Diagnóstico; Fetter y Thompson, Universidad de **Yale**): sistema de clasificación de pacientes (*case-mix*) en unos 1.000 grupos con **coherencia clínica** e **isoconsumo** de recursos.
  - **Peso relativo**: coste esperado frente al paciente medio (1,0). **Outliers**: casos extremos de estancia o coste.
  - Limitación: se basan en el **diagnóstico médico** y no recogen la variabilidad de cuidados de enfermería.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! Ingresa por apendicitis y sufre una parada en la UCI: el diagnóstico principal sigue siendo la **apendicitis**.

A6. Producto enfermero y sistemas de medición

Producto enfermero: suma de intervenciones autónomas e interdependientes, cuidados, educación y apoyo prestados para resolver diagnósticos y problemas de su competencia. Antes era invisible (un "gasto de hostelería" incluido en la estancia).

Es un **servicio**, no un objeto: **intangible**, **fugaz** (no se puede almacenar ni inventariar), **variable** según el entorno, **inseparable** (se produce y se consume a la vez) y **original**, con **participación del propio usuario**.

Sistema	Claves
PRN (***Project Research in Nursing***; **Tilquin, Quebec)**	**1 punto = 5 minutos**. Módulo I: atención directa/indirecta; II: comunicación (relevo, pase de visita, registros); III: mantenimiento de la unidad. **I + II = calidad**; **I + II + III = carga de trabajo**. 8 grupos de necesidades, 99 actividades, 249 factores; registro de 7 días
SIIPS (Francia; *soins infirmiers individualisés à la personne soignée*)	Basado en las **14 necesidades de Henderson**. Cuidados básicos, técnicos y de relación/educación
SIGNO I / II (INSALUD, el antiguo Instituto Nacional de la Salud)	Contabilidad analítica. **I**: coste **por servicio** (Grupo Funcional Homogéneo, GFH). **II**: coste **por paciente** y proceso; catálogo de productos enfermeros
NIPE (Normalización de las Intervenciones para la Práctica Enfermera; 1997, Ministerio)	Integra NANDA-NOC-NIC en los **GRD** (Normas de Enfermería); no los sustituye
VASS (Valoración de Actividades Asistenciales)	Clasifica el tiempo en atención **directa** (con el paciente) e **indirecta** (fuera de su presencia)

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! 12 puntos PRN = 60 min; 36 puntos = 3 horas.
>
> ! El relevo de turno y los registros están en el **Módulo II** (calidad), no en el III.

A7. Cartera de servicios

- Instrumento que hace **explícito y exigible** el conjunto de técnicas, tecnologías y prestaciones garantizadas.
- Inclusión: evaluación de seguridad, eficacia y eficiencia por la **RedETS** (Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS): valor clínico, impacto poblacional, mejora organizativa y coste-efectividad.
- **RD 1030/2006** (Real Decreto de la cartera de servicios comunes del SNS). Las Comunidades Autónomas (CC. AA.) pueden **añadir** técnicas que no estén en la común (carteras complementarias con fondos propios), **nunca recortar**.
- **RDL 16/2012** (Real Decreto-ley de sostenibilidad del SNS): divide la cartera común en **básica** (sin copago: AP, AE, **transporte urgente**), **suplementaria** (con aportación: farmacia, ortoprótesis, productos dietéticos, **transporte no urgente**) y **accesoria**.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Ambulancia urgente = cartera **básica** (gratis). Ambulancia programada (diálisis, rehabilitación) = **suplementaria** (copago).

A8. Recursos humanos: motivación, liderazgo y comunicación

Teorías de la motivación

Teoría	Claves
Maslow	Pirámide: fisiológicas, seguridad, sociales, estima, **autorrealización**. Un nivel superior no motiva hasta cubrir los inferiores
Herzberg (bifactorial)	**Higiénicos** o extrínsecos: dependen del **contexto** del trabajador en la empresa (salario, condiciones, política de la empresa); su falta genera insatisfacción, pero no motivan. **Motivadores** o intrínsecos: dependen del **contenido** del trabajo (reconocimiento, responsabilidad, autonomía, el trabajo en sí)
McClelland	Necesidades de **afiliación**, **logro** y **poder**
McGregor	**Teoría X**: el trabajador evita el esfuerzo y hay que controlarlo. **Teoría Y**: el trabajo satisface, se autodirige

Liderazgo

- **Transaccional**: intercambio, recompensas y castigos, tareas rutinarias. **Transformacional**: inspira y empodera; cambia la cultura. Es el estilo más recomendado para la **innovación, el compromiso y la calidad** (crea entornos de trabajo saludables).
- **Hospitales magnéticos (Magnet)**: atraen y **retienen** a las enfermeras (**baja rotación** de plantilla): dirección participativa, liderazgo transformacional, promoción, salarios competitivos, plantilla flexible y buenas relaciones entre profesiones.
- **Kurt Lewin**: **autocrático** (útil en emergencias, frustra a largo plazo), **democrático** (más compromiso y calidad) y **laissez-faire** (desorganización; solo para equipos muy autónomos).
- **Modelos situacionales o integradores**: ningún estilo es mejor siempre; la eficacia del liderazgo depende de **el líder, el seguidor y la situación**.

Hersey y Blanchard (situacional)	Estilo	Conducta del líder
M1: no sabe / no quiere o inseguro	**E1 Dirigir**	Alta tarea / **baja** relación
M2: no sabe / sí quiere	**E2 Persuadir**	Alta tarea / alta relación
M3: sí sabe / no quiere o inseguro	**E3 Participar**	Baja tarea / alta relación
M4: sí sabe / sí quiere	**E4 Delegar**	Baja tarea / **baja** relación

- **Comunicación**: asertividad y escucha activa; es una intervención de seguridad (el PRN le dedica el Módulo II).

TRAMPAS DE EXAMEN

! **Según Herzberg, el salario es un factor higiénico, nunca motivador.**
! M1 y M4 (los extremos) piden **baja relación**; solo M2 y M3 piden alta relación.
! En una parada cardiorrespiratoria, el estilo adecuado es el **autocrático/directivo**.

BLOQUE B · Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS

B1. Objeto, ámbito y prestaciones

- La Ley 16/2003 coordina el Sistema Nacional de Salud (SNS) una vez que todas las CC. AA. recibieron las competencias del antiguo INSALUD (Instituto Nacional de la Salud). Desarrolla los arts. **41** (Seguridad Social) y **43** (protección de la salud) de la Constitución Española (**CE**).
- **Objeto (art. 1)**: equidad, calidad y participación social; coordinación en prestaciones, farmacia, profesionales, investigación, información, calidad, planes integrales, salud pública y participación.
- **Derechos de los ciudadanos (art. 4)**: segunda opinión; tiempo máximo de espera en su comunidad de residencia; y, si está **desplazado** en otra comunidad, recibir allí la asistencia **en las mismas condiciones que los residentes de esa comunidad**.
- **No modifica** el régimen de las mutualidades de funcionarios: **MUFACE** (civiles del Estado), **MUGEJU** (justicia) e **ISFAS** (Fuerzas Armadas).
- **Prestaciones**: servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción. Solo por personal habilitado y en centros propios o concertados del SNS.
- Excepción: **riesgo vital inminente** fuera del SNS; se paga solo si se justifica que **no pudieron utilizarse** los medios del SNS.
- Extranjeros en estancia temporal: para prestaciones no urgentes, informe previo favorable de los **servicios sociales** autonómicos.
- **Atención Primaria (art. 12)**: nivel básico e inicial. Comprende la asistencia **a demanda, programada y urgente** (en consulta y en domicilio), la indicación y realización de **pruebas y tratamientos**, la prevención, promoción, atención familiar y comunitaria, la información y vigilancia en protección de la salud, la **rehabilitación básica**, la atención a mujer (incluida la detección de la violencia de género), infancia, adolescencia, adultos, mayores, grupos de riesgo y crónicos, los **cuidados paliativos** a enfermos terminales, la **salud mental** (coordinada con AE) y la **salud bucodental**.
- **Atención Especializada (art. 13)**: consultas, hospital de día, hospitalización, hospitalización a domicilio, paliativos, salud mental y la **rehabilitación de pacientes con déficit funcional recuperable** (esta no es de AP). Será **ambulatoria siempre que sea posible**. Según el anexo III del RD 1030/2006, la hospitalización en internamiento comprende la **asistencia médica, quirúrgica, obstétrica y pediátrica** o la realización de tratamientos o procedimientos diagnósticos.

Cartera común (arts. 8 a 8 quater; avalada por el Tribunal Constitucional en la sentencia STC 139/2016)

Cartera	Contenido	Financiación
Básica asistencial	AP, AE, transporte **urgente**	Pública íntegra, sin copago
Suplementaria	Farmacia con receta, ortoprótesis, productos dietéticos, transporte **no urgente**	Con aportación del usuario
Accesoria	Técnicas de apoyo no esenciales	Con aportación o reembolso

- **Enfermería en AP (RD 1030/2006, anexo II)**: Educación para la Salud (EpS) individual, grupal y comunitaria; vacunación; atención al crónico; atención domiciliaria a inmovilizados y cuidadores; cuidados paliativos.
- **Salud pública**: acciones **colectivas** (vigilancia epidemiológica, alertas, cribados prenatal, neonatal y oncológicos, seguridad alimentaria). **RD 568/2024**: Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública. En emergencias, las CC. AA. deben dar los datos al Ministerio.

- **Rehabilitación**: fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, solo si hay relación con un proceso tratado en el SNS.

B2. Actualización de la cartera y copago

- **Aprobación (art. 20)**: el contenido de la cartera común lo acuerda el Consejo Interterritorial del SNS (**CISNS**). En su redacción original, el art. 20 decía que la cartera se aprobaba **por Real Decreto, previo informe del CISNS** (así se aprobó el RD 1030/2006, y así lo preguntó el SMS en 2019).
- **Actualización (art. 21)**: por **Orden del Ministerio de Sanidad** con **acuerdo previo del CISNS**. Evaluación de tecnologías en red con las agencias autonómicas: eficacia, efectividad, seguridad, utilidad terapéutica y coste-efectividad. Las asociaciones de pacientes participan en el comité de Genética Clínica.
- Las **carteras complementarias** autonómicas se pagan **al 100% con presupuesto propio** (nunca con el Fondo de Cohesión).

Aportación farmacéutica (copago): Real Decreto-ley (RDL) 11/2026, de 12 de mayo (según el manual)

Colectivo	Renta	Aportación	Tope mensual
Activos	< 9.000 €	40%	8,23 €
Activos	9.000-17.999 €	40%	18,52 €
Activos	18.000-34.999 €	45%	61,75 €
Activos	35.000-59.999 €	45%	Sin tope
Activos	60.000-99.999 €	50%	Sin tope
Activos	≥ 100.000 €	60%	Sin tope
Pensionistas	< 18.000 €	10%	8,23 €
Pensionistas	18.000-59.999 €	10%	13,37 €
Pensionistas	60.000-99.999 €	10%	18,52 €
Pensionistas	≥ 100.000 €	60%	61,75 €
Mutualistas (MUFACE, ISFAS, MUGEJU)	Cualquiera	**30%**	Sin tope

- **Exentos (0%)**: Ingreso Mínimo Vital (IMV), rentas de integración, pensiones no contributivas, parados sin subsidio, discapacidad severa (menores con **≥ 33%**), síndrome tóxico, accidente de trabajo o enfermedad profesional.
- **Aportación reducida** (crónicos): **10% con tope de 4,98 € por envase**, sea cual sea la renta.
- **Dispensación hospitalaria**: **gratuita** para todos.

TRAMPAS DE EXAMEN

! El Ministerio **no** puede actualizar la cartera sin acuerdo del CISNS.

! Activo con 45.000 € paga 45% **sin tope**: los topes de activos solo llegan hasta 34.999 €.

! Un mutualista jubilado sigue pagando el **30%** sin tope.

B3. Garantías de las prestaciones

- **Arts. 23-29**: accesibilidad (23), **movilidad** (24: atención en cualquier CA en las mismas condiciones), **tiempo máximo** (25), información (26), seguridad y calidad (27-29).
- **RD 1039/2011** (Real Decreto de tiempos máximos de espera en el SNS): **180 días naturales** desde la prescripción, solo para **5 cirugías**: cardiaca valvular, cardiaca coronaria, **cataratas**, prótesis de **cadera** y prótesis de **rodilla**. Excluye trasplantes y reproducción asistida. Las CC. AA. pueden fijar plazos **más cortos**, nunca más largos.
- **Murcia (Decreto 25/2006 de tiempos máximos, completado por la Ley regional 5/2010, de 27 de diciembre)**: cirugía **150 días**, primeras consultas **50 días**, pruebas **30 días**, todos **naturales**. Superado el plazo, se puede pedir la derivación a un centro concertado a cargo del SMS.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Todos los plazos de espera son en **días naturales**.

! Una hernia inguinal no está entre las 5 cirugías del RD 1039/2011.

B4. Cohesión, sistema de información y gobernanza

Fondo	Para qué
Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS)	Asistencia de **alta complejidad** a pacientes derivados entre CC. AA. (en los CSUR, Centros, Servicios y Unidades de Referencia; trasplantes) y asistencia transfronteriza
Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) (RDL 16/2012)	Asistencia **ordinaria** a desplazados temporales: urgencias, AP, farmacia

- **Sistema de Información Sanitaria (SIS, arts. 53-56)**: datos de prestaciones, población protegida, recursos y financiación. El Ministerio elabora la **Encuesta Nacional de Salud**, el Barómetro Sanitario y el Índice Nacional de Defunciones. Incluye el CMDIC (RD 1093/2010, ver A5). Las brechas de seguridad se notifican a la **AEPD** (Agencia Española de Protección de Datos). Conexión con el Espacio Europeo de Datos de Salud y receta electrónica europea.
- **REPS** (Registro Estatal de Profesionales Sanitarios): titulaciones, especialidades y lugar de ejercicio de **todos** los profesionales, **públicos y privados**.
- **Tarjeta Sanitaria Individual (art. 57)**: la emite la **Comunidad Autónoma**; el Ministerio fija los datos básicos y genera el **CIP-SNS**, vitalicio, en la Base de Datos de Población Protegida. Lleva Braille.
- **Consejo Interterritorial del SNS (CISNS, arts. 69-73)**: es el **órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información** de los servicios de salud entre sí y con el Estado (art. 69). Lo preside el **Ministro/a de Sanidad**, con los **17 consejeros** autonómicos y representantes de Ceuta y Melilla. Comité Consultivo, comisiones y grupos de trabajo (solo asesoran). Aprueba la cartera común, las nuevas tecnologías y los planes integrales. Reglamento del **23 de julio de 2003**. Sus acuerdos se plasman en **recomendaciones** que se aprueban **por consenso** (art. 73), no por mayoría ni como instrucciones.
- **Planes de calidad del SNS (art. 61)**: los elaboran el Ministerio y las CC. AA. en el seno del CISNS, con los objetivos de calidad prioritarios (p. ej., promoción de la salud y prevención, fomento de la equidad y de la excelencia clínica); el Ministro da cuenta de su cumplimiento en el **Senado**.
- **Alta Inspección (arts. 76-79)**: órgano estatal que supervisa a las **Administraciones autonómicas** (no sanciona a profesionales) y elabora una memoria anual.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Turista de Albacete atendido en La Manga por una gastroenteritis: lo compensa el **FOGA**, no el FCS.

! El REPS incluye también a la **sanidad privada**.

! La TSI la emite el **SMS**; el CIP-SNS lo genera el **Ministerio**.

Otras preguntas del test de este tema

Estas preguntas del EIR caen en el test de este tema aunque su materia es de otros apartados del programa (calidad asistencial). Aquí tienes lo necesario para responderlas.

- **PROMs y PREMs**: los **PROMs** son cuestionarios con los **resultados en salud** que informa el propio paciente; los **PREMs**, con su **experiencia** con la atención (trato, esperas, información).
- **Modelo EFQM** (European Foundation for Quality Management): modelo de **excelencia** o calidad total que puede usar cualquier organización, sanitaria o no. En su versión clásica tiene **9 criterios**: **5 agentes** (lo que la organización hace: liderazgo, política y estrategia, personas, alianzas y recursos, procesos) y **4 resultados** (lo que consigue: en los clientes, en las personas, en la sociedad y resultados clave). Los agentes explican **cómo** actuar; los resultados miden **qué** se ha logrado.